PROTOCOLLO 69

Programma domiciliare progressivo in 3 fasi

Organizzare gli esercizi dalla fase acuta al mantenimento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	10 minuti	A ogni cambio di fase

Indicazioni

- ✓ Pianificazione del lavoro a casa
- ✓ Dimissione graduale
- ✓ Prevenzione delle recidive

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Fase 1

Autogestione, posizione di riposo, aperture lente.



Fase 2

Controllo motorio, coordinazione, isometrie lievi.



Fase 3

Resistenza progressiva e integrazione cervicale.



Mantenimento

Programma breve da continuare dopo la dimissione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Fase 1	1 a 2 settimane
Fase 2	2 a 4 settimane
Fase 3	dalla 4ª settimana

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	____ / 10	Retta / Deviata
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Passa alla fase successiva in base ai criteri, non al calendario
- ✓ Scheda scritta per ogni fase
- ✓ Verifica l'aderenza

Errori da evitare

- ! Troppi esercizi insieme
- ! Saltare le fasi
- ! Nessun programma di mantenimento

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Programma di mantenimento	3 esercizi scelti insieme al paziente	5 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Un programma per fasi chiaro migliora l'aderenza e riduce le ricadute.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.